



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

SENTENÇA

Cuida-se de ação de indenização por danos estéticos e morais ajuizada por CLEUDILENE BRILHANTE MATOSINHO em face de REGINALDO FONSECA CHAVES E FONSECA CHAVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

Argumenta a autora que houve falha na prestação de serviço pelo requerido, pois alegou que pagou pelo atendimento e tratamento com o requerido e que lhe foi cobrada duas vezes pelo retorno médico, ocasião em que houve recusa do atendimento.

Relatou que foi atendida em 26/09/2016 com retorno em 31/10/2016 e 14/11/2016. Ao retornar para o tratamento em 05/12/2016, lhe foi cobrado pela consulta e diante da falta de pagamento, o atendimento foi recusado. Alegou que estava com muita dor no olho esquerdo e quase sem enxergar. Aduz que não tinha como pagar pela consulta e alega que devido a não ter como custear, houve a recusa do atendimento médico e agravamento do seu estado de saúde. Alegou que o requerido foi negligente. Pugnou pela aplicação da teoria da perda de uma chance.

Citado, o requerido alegou que a paciente foi atendida em 26/09/2016 e que retorno foi agendada para o dia 31/10/16 e 14/11/2016. Aduziu que a paciente não retornou para o atendimento nas datas e que a paciente não teria iniciado o tratamento e utilização a medicação. Nesse sentido, argumenta que não foi seguida a prescrição médica e que por isso, não houve melhora. Relatou que atendeu a paciente em 31/10/2016 e que constatou que não foi utilizada a medicação prescrita, logo, o quadro permanecia inalterado. Assim, solicitou que a autora retornasse após dois dias depois de ter iniciado o uso do medicamento e após o término do prazo de 10 (dez) dias. Alegou que a patologia (úlceras oculares) apresentada era uma infecção da córnea, não sendo indicado a intervenção cirúrgica. Relatou que no período que a autora realizou consulta com o requerido não havia perfuração da córnea, portanto, não havia necessidade de intervenção cirúrgica. Destacou a resolução nº 1.985/2010, de 10/01/2011, que define o que é consulta e o

prazo de retorno. Nesse sentido, argumenta que atendeu a autora em duas consultas de retorno e que a paciente não fez uso da medicação prescrita, por ausência de condições financeiras. Portanto, argumentou que a responsabilidade pelo agravamento da enfermidade foi da parte autora. pugnou pelo indeferimento da ação.

Em réplica, a autora ratificou suas alegações.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o informante MAYKON SILVA FERNANDES, a testemunha TELMA ROSANA VIRGENS GONZAGA e a testemunha MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BORGES da autora.

As partes apresentaram seus memoriais finais.

É o relato. **Decido.**

Da Dispensa da Produção de Provas e do Julgamento Antecipado do Mérito.

O requerido pugnou pela realização de perícia médica documental para fins de análise do quadro de saúde da autora por ocasião da realização dos exames, sob o fundamento de que ao realizar o atendimento na época, não era indicado a intervenção cirúrgica.

Contudo, não há necessidade de produção da referida prova. Constata-se que nos autos a prova suficientes para julgamento do mérito. além disso, os laudos e exames são claros e não demandam uma análise aprofundada para seu entendimento.

Portanto, **INDEFIRO** o pedido de prova pericial do requerido, com fulcro no art. 370, parágrafo único do CPC.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a julgar o pedido imediatamente quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do requerido por imperícia médica no

tratamento da autora e pela perda da chance da autora em recuperar a visão do olho direito.

Inicialmente, cumpre reiterar que a presente demanda será analisada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa. Cabe ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado, nos termos do art. 14, §4º do CDC.

Tal responsabilidade exige nexos causais entre o dano experimentado e o serviço médico prestado. Contudo, no caso dos autos, não se evidencia que houve demora na realização de exames ou na prescrição de medicamentos ao tratamento da autora.

Compulsando as provas produzidas nos autos, observa-se que os documentos apresentados pela parte autora indicam que ela foi atendida em 26/09/2016 pelo requerido, com retorno em 31/10/2016 e 14/11/2016. Ao retornar para o tratamento, em 05/12/2016, teria sido recusado atendimento devido à falta de pagamento de nova consulta, sustentando que tal fato piorou sua enfermidade e prejudicou sua chance de recuperação, o que levou à cegueira. Contudo, as provas apresentadas pela autora também comprovam demora em procurar atendimento médico, após a consulta original. Os laudos juntados pela autora indicam que nova avaliação médica foi realizada em 20/02/2017 e o laudo oftalmológico de 24/03/2017.

De outra banda, o requerido comprovou que realizou a consulta da autora, na mesma data realizou exames oftalmológicos, além da prescrição de medicação por três vezes. Além disso, o requerido alegou que não houve o uso da medicação de forma correta pela autora, fato não refutado pela autora.

Por conseguinte, a prova testemunhal produzida corroborou as alegações da parte requerida. O informante MAYKON SILVA FERNANDES confirmou a realização dos exames na autora de topografia, retinografia, microscopia especular e campimetria e que a própria autora relatou ao técnico que não usou os medicamentos, pois alegou que não tinha dinheiro para adquirir os medicamentos.

A testemunha Thelma Rosana Virgens Gonzaga também corroborou que o tratamento indicado foi o correto, além das sequelas do não tratamento, que é a perfuração ocular, a depender da ação do patógeno. Do mesmo modo MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BORGES também confirmou que a autora não utilizou a medicação prescrita pelo requerido. Confirmou que o requerido chegou a fornecer alguns dos medicamentos à autora.

De acordo com a teoria da perda de uma chance, a expectativa ou a chance de alcançar um

resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, portanto, ser indenizado. Assim, a simples privação indevida da chance de cura ou sobrevivência é passível de ser reparada.

Para a aplicação da referida teoria nas situações em que é discutida a ocorrência de erro médico, segundo o Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário observar: (i) uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo; (ii) uma ação ou omissão do defensor que tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); (iii) o fato de que o dano não é o benefício perdido, porque este é sempre hipotético (REsp 1104665/RS, DJe 04/08/2009; REsp 1254141/PR, DJe de 20/02/2013; REsp 1622538/MS, DJe 24/03/2017).

O nexo causal que autora a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida. A conduta a ser atribuída seria com relação à demora no atendimento em consulta ou exame médico ou ainda erro no diagnóstico.

Para atribuir o resultado ao requerido, com base na teoria da perda de uma chance de tratamento adequado, deveria ser comprovado o liame causal entre a conduta do requerido e o resultado.

Na questão em análise, devido à demora na procura de continuidade do tratamento pela parte autora houve a quebra do nexo causal apto a imputar ao requerido eventual responsabilidade pelo agravamento do quadro de saúde da autora, o que afasta sua responsabilidade no evento. Não é possível concluir que houve erro ou falha passível de caracterizar uma frustração de chance concreta de cura, com alto grau de probabilidade de recuperação da autora, pois esta demorou a dar continuidade ao tratamento ocular. Assim, afastada qualquer alegação da autora no sentido de que a conduta do requerido teria privado a autora de alguma chance de cura.

Além disso, os exames foram realizados no próprio consultório do requerido, além das várias consultas realizadas não indicam falha na prestação do serviço. Com relação a possível erro de diagnóstico, não há como se concluir nesse sentido, pois houve uma demora excessiva da parte autora em dar continuidade ao tratamento, pois, ao que relatou na inicial, sentia dor constante, o que se presume, não demoraria a procurar atendimento médico, o que não indicam as provas dos autos.

Com relação à cobrança por nova consulta, fato que a autora atribuiu como agravante da situação e que teria levado a sua cegueira, este não restou comprovado nos autos, além disso, não se tratava de situação emergencial, que exigiria um pronto atendimento médico. Ademais, foram realizados vários 03 (três) atendimentos médicos pelo requerido e restou comprovado que a autora não usou a medicação prescrita, fato que não pode ser imputado ao requerido, o que não tem obrigação de fornecer medicação, mas que chegou a fornecer alguns colírios por cortesia.

Assim, o retardo no tratamento da enfermidade pode ter sido afetado por diversos fatores, mas não há como imputar a responsabilidade ao requerido se a própria autora não usou a medicação pela autora na data prescrita, conforme confirmou a prova testemunha produzida nos autos. As provas dos autos não indicam a responsabilidade do requerido pelo agravamento do estado de saúde da autora. Ao passo que a conduta da autora é mais apta a indicar o agravamento de sua enfermidade pelo retardamento do uso da medicação.

Por conseguinte, quanto à alegação de erro de diagnóstico, não há elementos nos autos que indiquem erro do requerido, e em razão da demora no uso da medicação pela própria autora, associado à demora em procurar a continuidade do tratamento médico, são fatores que quebraram o nexo de causalidade dos fatos a serem imputados ao requerido quanto ao resultado.

Portanto, não restou demonstrado quanto à existência de nexo de causalidade entre o atendimento do requerido e a perda da visão do olho direito e a sequela permanente. Ausente nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta profissional, não há que se falar em responsabilidade, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, impugnam as razões de decidir da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que não pode ter aplicação banal. Nos termos dos artigos 186, do CC, e 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para caracterização a comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta do profissional. A responsabilidade das clínicas médicas e das operadoras de planos de saúde é objetiva, tendo em vista serem fornecedores de serviços médicos e hospitalares, nos termos dos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, e 14, caput, do CDC. Não comprovado erro, negligência, imprudência, imperícia e o nexo causal entre o atendimento prestado médicos credenciados do réu e as doenças acometida pela autora, deve ser mantida a improcedência do pedido de reparação por danos morais, estéticos ou perda de uma chance. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.340249-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. SEGURADORA. VIGÊNCIA DE APÓLICE. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ART. 14, § 4º DO CDC. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. CORPO ESTRANHO. DIAGNÓSTICO TARDIO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE. DANO, CULPA (NEGLIGÊNCIA) E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA HOSPITALAR. EXISTÊNCIA. RESULTADO DE EXAME INCORRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA "PERDA DE UMA CHANCE". POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - "O vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu " (STJ, AgInt no AREsp: 2107799/PR). - É incabível "a denúncia da lide nos casos em que a denunciante postula somente o reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua a natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais" (STJ, AgRg no REsp: 1483211/RJ). - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil). A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4º do CDC). - O médico deve agir com diligência e cuidado no exercício de sua profissão, sem olvidar do consagrado juramento de Hipócrates e das normas previstas no Código de Ética Médica. Ademais, é imprescindível o fornecimento de informações - claras, detalhadas e corretas - sobre o estado de saúde do paciente, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica. - O excessivo e angustiante período de espera por um diagnóstico correto é capaz de causar danos morais indenizáveis ao paciente, que perde a oportunidade de realizar um tratamento eficaz, com profundo sofrimento emocional e grande impacto negativo na qualidade de vida. - No caso, o conjunto probatório evidencia a omissão do médico, que não tomou providências concretas no sentido de descobrir a causa dos severos sintomas relatados pelo paciente (dores intensas e persistentes no olho direito), que evoluíram para um quadro de cegueira

irreversível. - "A responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa" (STJ, REsp: 1511072/SP). "Se o resultado do exame de ultrassom apresenta informações em desconformidade com a realidade do paciente, em decorrência do diagnóstico incorreto, tem o hospital a responsabilidade pelo ato. O defeito na prestação de serviço ao consumidor enseja a responsabilização do hospital pelos danos morais sofridos pela paciente" (TJMG - AC: 1.0701.10.010027-3/001). - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. "Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional" (STJ, REsp: 1254141/PR). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.170667-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felipe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)

Desse modo, a ausência de falha na prestação do serviço associada a falta de comprovação de conduta ilícita rompe a relação de causalidade e afasta o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido.

Assim, não há como imputar ao requerido a responsabilidade pelo resultado decorrente do agravamento da lesão que deixou a autora com as sequelas no olho direito pela ausência de nexos causal, além de não evidenciada qualquer falha na prestação do serviço, o que afasta qualquer alegação de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito da lide.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades legais devidas, servindo essa de expediente de comunicação.

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente Sentença como Carta de Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Datado e assinado pela magistrada.

RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Portaria n. 3890/2025-GP

